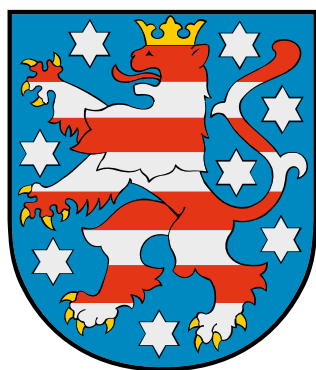




**Thüringer Ministerium
für Bildung, Wissenschaft und Kultur**

**Lehrplan
für berufsbildende Schulen**

Schulform: Berufliches Gymnasium

Fachrichtung: Gesundheit und Soziales

Fach: Gesundheit und Soziales

Qualifikationsphase

2025

Erprobungsfassung

Herausgeber:
Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur
Werner-Seelenbinder-Straße 7
99096 Erfurt

Inhaltsverzeichnis

1	Das berufliche Gymnasium in Thüringen	4
2	Kompetenz- und standardorientierter Unterricht im beruflichen Gymnasium in Thüringen	6
3	Ziele der Kompetenzentwicklung im Fach Gesundheit und Soziales	9
3.1	Fachliche Konzeption zum Kompetenzerwerb	9
3.2	Inhaltsbezogene Kompetenzen.....	13
3.2.1	Vielfalt von Gesundheit und Krankheit im Lebenslauf (Q1).....	13
3.2.2	Gesundheit und Pädagogik in Wechselwirkung (Q2).....	16
3.2.3	Lernen als konstruktiver Prozess der Gesundheitsförderung (Q3).....	19
3.2.4	Gesundheit und Identität (Q4)	22
4	Einschätzung der Kompetenzentwicklung	26
4.1	Zur Leistungseinschätzung im kompetenz- und standardorientierten Unterricht	26
4.2	Leistungsbewertung im Fach Gesundheit und Soziales	28

1 Das berufliche Gymnasium in Thüringen

Das Thüringer Schulgesetz formuliert den Bildungs- und Erziehungsauftrag für die Thüringer Schulen und benennt als wesentliche Ziele der Schule

- die Vermittlung von Wissen und Kenntnissen,
- die Entwicklung von Fähigkeiten und Fertigkeiten,
- die Vorbereitung auf das Berufsleben,
- die Befähigung zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und zur Mitgestaltung der freiheitlichen demokratischen Grundordnung sowie zum bewussten, selbstbestimmten und kritischen Umgang mit Medien,
- die Erziehung zur Aufgeschlossenheit für Kultur und Wissenschaft sowie
- die Achtung vor den religiösen und weltanschaulichen Überzeugungen anderer.

Die Lernenden erwerben Kompetenzen, um ihre Beziehungen zu anderen Menschen nach den Grundsätzen der Gerechtigkeit, der Solidarität und der Toleranz sowie der Gleichberechtigung der Geschlechter bewusst zu gestalten. Sie werden darauf vorbereitet, Aufgaben in Familie, Gesellschaft und Staat zu übernehmen und ein Verantwortungsgefühl für die Menschen zu entwickeln. Die Schule fördert den Reifungsprozess der Lernenden zur Ausbildung ihrer Individualität, zu Selbstvertrauen und eigenverantwortlichem Handeln¹. In der Verantwortung der Lehrkräfte in enger Zusammenarbeit mit den Eltern liegt es, diesen Prozess zu begleiten und entwicklungsfördernd zu gestalten.

Der Bildungs- und Erziehungsauftrag für das berufliche Gymnasium in Thüringen orientiert sich an

- der Stärkung der ganzheitlichen Allgemeinbildung,
- der Vermittlung einer vertieften Allgemeinbildung mit einer fundierten Sprachenbildung und beruflichen Kenntnissen,
- der individuellen Förderung jedes Lernenden und
- der Eigenverantwortung von Schulen auf der Basis eines schulinternen Qualitätsmanagements.

Primäres Ziel schulischen Lernens ist die Sicherung der Grundbildung. Dazu werden Kompetenzen ausgebildet, wobei die Entwicklung von Lernkompetenzen im Mittelpunkt steht. Dies impliziert grundlegende Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten im literarisch-sprachlichen, mathematisch-naturwissenschaftlich-technischen und gesellschaftswissenschaftlichen Bereich, ein breites Allgemeinwissen sowie methodische, sozial-kognitive und soziale Kompetenzen.

Das berufliche Gymnasium führt die Klassenstufen 11 bis 13. Es vermittelt eine vertiefte allgemeine Bildung, die zur allgemeinen Hochschulreife führt und Voraussetzung für die Aufnahme eines Studiums ist. Darüber hinaus erwerben die Lernenden berufliche Kenntnisse in der gewählten Fachrichtung (Gesundheit und Soziales, Technik oder Wirtschaft) und werden damit auf eine sonstige berufliche Ausbildung vorbereitet.

Mit dem Übergang zum beruflichen Gymnasium werden die Lernenden in der Klassenstufe 11 in einer Einführungsphase auf das Lernen in der Qualifikationsphase vorbereitet. Durch gezielte Förderung sollen schulartspezifische Unterschiede zwischen den Lehrplänen der Regelschule und des allgemein bildenden Gymnasiums, insbesondere in den oberen Klassenstufen, ausgeglichen werden, so dass das Ausgangsniveau der Klassenstufe 10 des allgemein bildenden Gymnasiums gesichert wird.

¹ § 2 Thüringer Schulgesetz (ThürSchulG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 30. April 2003 (GVBl. S. 238), in der jeweils geltenden Fassung.

Die Vertiefung grundlegender Kompetenzen, der erhöhte Anspruch an die Selbstständigkeit der Lernenden sowie die Vervollkommnung der Methoden wissenschaftspropädeutischen Lernens kennzeichnen die Klassenstufen 12 bis 13.

Die aktive und eigenverantwortliche Gestaltung der Lernprozesse durch die Lernenden steht zunehmend im Mittelpunkt. Je nach Entwicklungsstand können sie

- fundiertes Allgemeinwissen nachweisen,
- fachübergreifende Aspekte bei der Bearbeitung komplexer Zusammenhänge einbeziehen,
- eigenverantwortlich, konzentriert und leistungsorientiert arbeiten,
- logisch, systematisch und vernetzt denken,
- Probleme selbstständig, kreativ und konstruktiv lösen,
- mit anderen kommunizieren und kooperieren,
- Techniken der Präsentation sachbezogen und situationsgerecht anwenden,
- Sachverhalte, Handlungen und Personen kritisch beurteilen,
- über Lernergebnisse und -prozesse sachgerecht und altersgemäß reflektieren.

Im beruflichen Gymnasium werden in der Qualifikationsphase Fächer mit grundlegendem Anforderungsniveau und Fächer mit erhöhtem Anforderungsniveau ausgewiesen. Die fachlichen Kompetenzen und Inhalte des Unterrichts mit erhöhtem Anforderungsniveau unterscheiden sich von denen des Unterrichts mit grundlegendem Anforderungsniveau in

- der thematischen Erweiterung und der theoretischen Vertiefung,
- der Verknüpfung und Reflexion von Methoden und Strategien,
- der Form der wissenschaftstheoretischen Reflexion,
- der Tiefe des fachspezifischen Zugriffs,
- dem Grad der Vorstrukturierung,
- dem Schwierigkeits- und Komplexitätsgrad sowie der Offenheit der Aufgabenstellung,
- dem Umfang und der Art bereitgestellter Informationen und Hilfsmittel.

Im Unterricht mit erhöhtem Anforderungsniveau müssen Transferleistungen und problemlösendes Denken in quantitativ und qualitativ höherem Maße eingefordert und erbracht werden.

2 Kompetenz- und standardorientierter Unterricht im beruflichen Gymnasium in Thüringen

Globalisierung, eine hohe Mobilität und Flexibilität in der Arbeitswelt, eine multikulturelle und multimediale Umgebung, rasante Entwicklung von Technologien, veränderte Berufsbilder, die Wissensexplosion, neue Familienstrukturen sowie eine zunehmende Individualisierung erfordern ein neues Verständnis von Lehr- und Lernprozessen. Schule steht vor der Herausforderung, Bildungs- und Erziehungsprozesse zu gestalten, in denen der individuelle Lernerfolg der Lernenden und ihr Handeln im Mittelpunkt stehen.

Die jeweiligen Fachlehrpläne des beruflichen Gymnasiums benennen die verbindlichen zentralen (unverzichtbaren) fachspezifischen und ggf. aufgabenfeldspezifischen Kompetenzen, einschließlich der zugrundeliegenden Wissensbestände des Unterrichtsfachs sowie die Lernkompetenzen, die alle Lernenden – mit Unterstützung – bis zu einem bestimmten Zeitpunkt ihres Bildungsgangs erworben haben.

Ein kompetenz- und standardorientierter Unterricht erfordert folglich den konsequenten Blick auf das, was die Lernenden zu einem bestimmten Zielzeitpunkt, am Ende einer Klassenstufe sowie am Ende eines Bildungsgangs fachlich-inhaltlich, methodisch-strategisch, sozial-kommunikativ und selbstregulierend können sollen. Mit dieser Zielsicht bindet ein kompetenz- und standardorientierter Unterricht die Entwicklung von Kompetenzen an handlungs- und problemorientiertes Lernen, an sinnvolle Aufgaben und Problemstellungen.

Die Konzentration der Lehrpläne auf zentrale Kompetenzen und zentrale Inhalte einerseits und die ergebnisbezogene Formulierung der Ziele des Kompetenzerwerbs andererseits führen auch im beruflichen Gymnasium dazu, dass Ziele und Inhalte in den Lehrplänen nicht mehr so stark sequenziert werden.

Die Aufgabe der Lehrenden ist es, einen ganzheitlichen und fachlich abgestimmten Lehr- und Lernprozess zu konzipieren, in dessen Verlauf die erforderlichen Kompetenzen im Sinne eines kumulativen Lernens spiralcurricular entwickelt werden können. Dies setzt schulinterne Entscheidungen zur Ziel- und Inhaltspräzisierung zentraler Vorgaben, zur fächerübergreifenden Kooperation, zu individuellen Fördermaßnahmen, zur Lernstandskontrolle, zur Einbeziehung außerschulischer Lernorte usw. voraus, damit alle Lernenden die in den Lehrplänen ausgewiesenen Kompetenzen erwerben können.

Für die Ausgestaltung von Lehr- und Lernprozessen tragen Lehrkräfte die pädagogische Verantwortung. Ihr professionelles Handeln erfordert

- die Organisation aktivierender, herausfordernder und auf Kooperation der Lernenden orientierende Lerngelegenheiten,
- die Moderation, Anleitung und problem- und anwendungsorientierte Gestaltung von Lernprozessen,
- die Einbeziehung der Lebenswelt der Lernenden,
- die Verknüpfung des Erwerbs von fachspezifischen und überfachlichen Kompetenzen,
- das Erfahren sozialen und demokratischen Handelns,
- die Förderung der Eigenverantwortung und Selbsttätigkeit der Lernenden,
- die Stärkung der Fähigkeit der Selbsteinschätzung von Lernenden,
- die Beratung der Lernenden in ihrem Lernprozess,
- die Reflexion der Ergebnisse und Prozesse des Lernens der Lernenden sowie die Ableitung von Konsequenzen für das eigene pädagogische Handeln.

Gleichwohl tragen auch die Lernenden zur Gestaltung erfolgreicher Lehr- und Lernprozesse Verantwortung. Sie lernen

- zunehmend eigenverantwortlich auf individuellen Wegen entsprechend ihren Lernvoraussetzungen, Lernstrategien usw., ihr Wissen und ihre Erfahrungen in neuen Zusammenhängen anzuwenden,
- voneinander und miteinander in verschiedenen sozialen Kontexten das eigene Lernen zu beobachten und zu bewerten sowie
- konstruktive Rückmeldung einzufordern.

Im beruflichen Gymnasium wird, genau wie im allgemein bildenden Gymnasium, eine vertiefte Allgemeinbildung vermittelt, zu der jedes Fach seinen spezifischen Beitrag leistet.

Die Entwicklung von Lernkompetenzen mit Methoden-, Selbst- und Sozialkompetenz steht im Mittelpunkt, da sie von zentraler Bedeutung für den kompetenten Umgang mit komplexen Anforderungen in Schule, Beruf und Gesellschaft ist. Lernkompetenzen werden in jedem Unterricht fachspezifisch ausgeprägt und sind daher von der Sachkompetenz nicht zu lösen. In ihrer grundsätzlichen Funktion weisen sie jedoch über das einzelne Fach hinaus.

Sachkompetenz wird für jedes Fach durch zentrale fachspezifische Kompetenzen konkretisiert, d. h. die Lernenden können

- erworbenes Wissen sowie gewonnene Einsichten in Handlungszusammenhängen anwenden,
- vorausschauend denken und
- sachbezogen urteilen.

Methodenkompetenz bedeutet, effizient lernen und Aufgaben gezielt bewältigen zu können, d. h., die Lernenden können

- Aufgabenstellungen sachgerecht analysieren und Lösungsstrategien entwickeln,
- Arbeitsschritte zielgerichtet planen und umsetzen,
- Informationen beschaffen, gezielt auswählen, speichern, veranschaulichen, (aus-)werten und austauschen,
- Informationen aus Quellen und Handlungen entnehmen, be- bzw. verarbeiten, zielangemessen lesen und verschriftlichen,
- Kontrollverfahren aufgabenadäquat einsetzen sowie
- Arbeitsergebnisse und Lösungswege verständlich und anschaulich präsentieren.

Selbstkompetenz bedeutet, selbstregulierend lernen zu können, d. h., die Lernenden können

- sich selbst Arbeits- und Verhaltensziele setzen,
- zielstrebig und ausdauernd lernen,
- sorgfältig arbeiten und Lernzeiten planen,
- eigene Lernwege reflektieren und Lernergebnisse bewerten,
- den eigenen Lernfortschritt und das eigene Arbeits- und Sozialverhalten einschätzen,
- selbstständig und situationsbezogen Lernstrategien und Arbeitstechniken auswählen und anwenden sowie
- Sachverhalte, Vorgänge, Personen und Handlungen aus der Perspektive von anderen betrachten.

Sozialkompetenz bedeutet, mit anderen gemeinsam lernen und kommunizieren zu können, d. h., die Lernenden können

- in kooperativen Arbeitsformen lernen,
- Verantwortung für den gemeinsamen Lernprozess übernehmen,
- andere motivieren,
- Hilfe geben und annehmen,
- Regeln und Vereinbarungen einhalten,

- einen eigenen Standpunkt entwickeln und begründet vertreten,
- adressaten- und situationsgerecht kommunizieren und argumentieren,
- mit persönlichen Wertungen angemessen umgehen und
- Ergebnisse und Wege gemeinsamer Arbeitsprozesse und die Leistung des Einzelnen in der Gruppe ein- und wertschätzen.

In der didaktischen Gestaltung des Fachunterrichts sind Vielfalt und Ausgewogenheit der Unterrichtsformen je nach Zielstellung, Lerninhalt und der jeweiligen Klassensituation erforderlich.

Jedes Unterrichtsfach besitzt seine eigene fachliche Struktur sowie didaktische Besonderheiten und baut Wissen kumulativ auf. Zahlreiche Fragestellungen und Inhalte erfordern aufgrund ihrer Komplexität fächerübergreifendes Arbeiten. Sie ermöglichen auch den Bezug zu folgenden Querschnittsaufgaben:

- Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE),
- Medienbildung,
- Demokratiebildung,
- durchgängige Sprachbildung,
- berufliche und arbeitsweltliche Orientierung.

Erfolgreiches fächerübergreifendes Arbeiten erfordert eine kontinuierliche Lehr- und Lernplanung, die in jeder Klassenstufe fächerübergreifende Frage- bzw. Problemstellungen verbindlich ausweist.

Im Unterricht sind individuelle Lernwege zu ermöglichen, die den jeweiligen Stand der Kompetenzentwicklung berücksichtigen. Dies setzt diagnostische Maßnahmen und daraus resultierende differenzierte Angebote voraus. Die individuelle Förderung betrifft grundsätzlich alle Lernenden mit besonderen Begabungen, Lernschwierigkeiten, mit Migrationshintergrund, sonderpädagogischem Förderbedarf bzw. mit sozial begründeten geringeren Bildungschancen bedürfen besonderer pädagogischer Förderung.

3 Ziele der Kompetenzentwicklung im Fach Gesundheit und Soziales

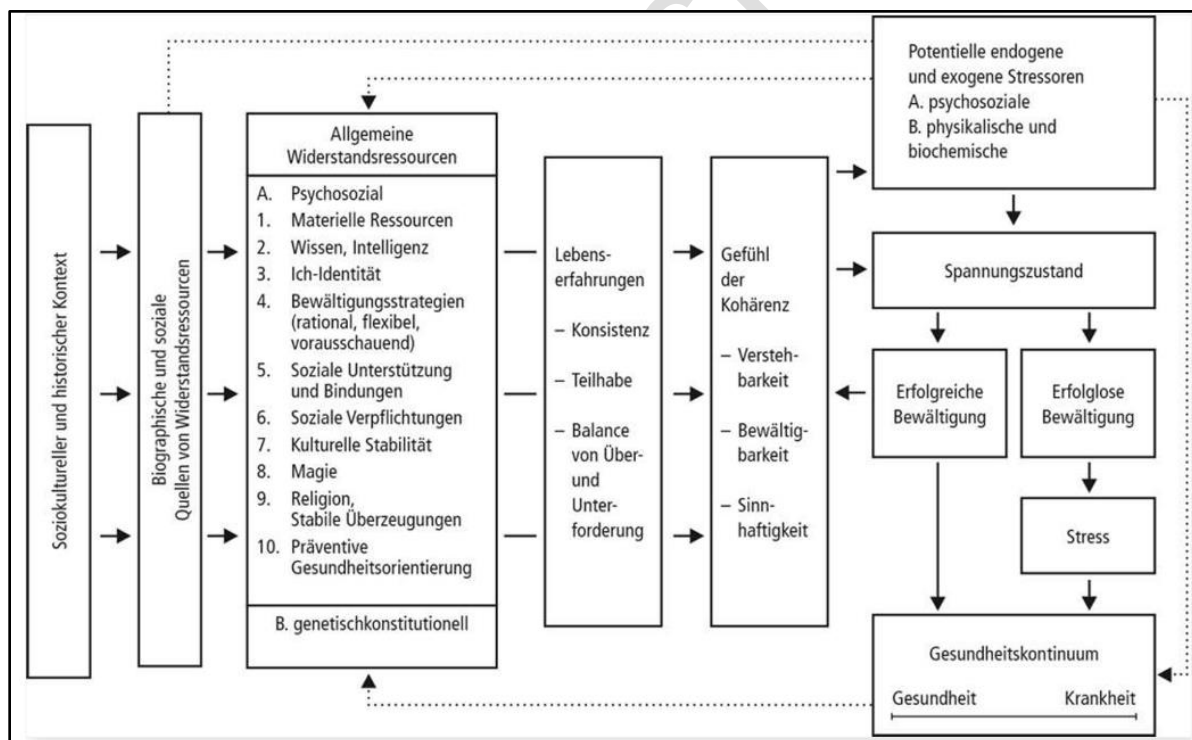
3.1 Fachliche Konzeption zum Kompetenzerwerb

Das Fach Gesundheit und Soziales beinhaltet grundsätzliche Aspekte der Gesundheits- und Sozialwissenschaften, welche interdisziplinär verknüpft und vermittelt werden.

Das zentrale Ziel des Faches ist die Anbahnung eines Bewusstseins für gesundheitsförderndes Verhalten im individuellen und sozialen Kontext. Grundlegend ist dabei ein salutogenetisch orientiertes Verständnis von Gesundheit, welches den Menschen als bio-psycho-soziale Einheit in den Mittelpunkt rückt. Das von Aaron Antonovsky² in die gesundheitswissenschaftliche und gesundheitspolitische Diskussion eingebrachte Konzept der Salutogenese bildet den theoretischen Rahmen und ermöglicht vielfältige Bezüge zu sozialwissenschaftlichen Inhalten.

Dementsprechend werden verwandte Konzepte und Theorien zur Erklärung von Gesundheit und Krankheit, des Verhaltens (z. B. Health Action Process Approach – HAPA, Konzept der Selbstwirksamkeit aus der sozial-kognitiven Theorie, Lerntheorien) sowie zur Stress- und Resilienzforschung (z. B. Transaktionales Stressmodell nach Lazarus) fachwissenschaftlich übergreifend beleuchtet und kritisch reflektiert.

Die folgende Abbildung zeigt das komplexe Gefüge der Bedingungen, die Gesundheit im Sinne von Antonovsky erklären sollen³.



Antonovsky kritisiert die in modernen Industriegesellschaften nach wie vor dominante pathogenetische Betrachtungsweise von Gesundheit, in deren Mittelpunkt die Beschwerden, Symptome oder Schmerzen des Patienten stehen, welche ärztlicher Behandlung bedürfen (biome-

² israelisch-amerikanischer Soziologe und Professor der Soziologie, 1923 - 1994

³ Faltermaier, T.: Gesundheitspsychologie. W. Kohlhammer GmbH, Stuttgart, 2023, 3. Auflage, S. 80.

dizinisches Krankheitsmodell). In dieser Tradition steht die internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme (ICD-10). Symptome sind Folge organischer Defekte – der eigentlichen Krankheit. Folglich ist der Mensch entweder gesund oder krank. Der kranke Mensch wird als Subjekt und Handelnder weitgehend ausgeklammert. Psychische Prozesse sind nicht relevant. Risikofaktoren erhöhen in dieser Vorstellung die Erkrankungs-wahrscheinlichkeit. Prävention zielt auf die Vermeidung der Risikofaktoren und Verhaltensänderung⁴.

Die durch den Sozialmediziner Engel vorgenommene Erweiterung des Modells trägt Studien-ergebnissen Rechnung, wonach psychische und soziale Faktoren bei der Entstehung, für die Diagnose, den Verlauf und die Behandlung von Krankheiten von Bedeutung sind⁵. Vor diesem Hintergrund rücken u. a. Fragen nach den Gefühlen der betroffenen Personen, ihrem Umfeld und ihrem Umgang mit der Erkrankung in den Fokus des Interesses, was Kenntnisse in vielfältigen sozialwissenschaftlichen Themengebieten erfordert.

Auf Basis des so entstandenen bio-psycho-sozialen Modells und der damit verbundenen erweiterten Blickrichtung legt Antonovsky der Beziehung von Gesundheit und Krankheit die Vorstellung eines Kontinuums zu Grunde, auf dem Menschen als mehr oder weniger krank bzw. gesund eingestuft werden können. Völlige Gesundheit oder Krankheit sind in diesem Verständnis nicht zu erreichen. Somit verzichtet er zugleich auf eine absolute, idealistische Gesundheitsdefinition, da Gesundheit nicht als vollkommener Zustand, sondern als kontinuierlicher Prozess verstanden wird⁶.

„Der Gesundheits- bzw. Krankheitszustand eines Menschen hängt laut Antonovsky bei vergleichbaren äußeren Bedingungen von der Ausprägung einer [...] individuellen, sowohl kognitiven als auch affektiv-motivationalen Grundeinstellung [...] ab“, was er als Kohärenzgefühl bezeichnet⁷.

Diese Grundhaltung, die Welt als verstehbar, sinnvoll und bewältigbar zu erleben, entwickelt sich durch kohärente Lebenserfahrungen und Widerstandsressourcen. Zusätzlich zur ausschließlichen Therapie organischer Störungen und dem Ausschalten von Risikofaktoren wird somit auf die Nutzung und Stärkung vorhandener Ressourcen fokussiert, um den Organismus widerstandsfähiger zu machen⁸. Die Entstehung und das Vorhandensein dieser Widerstandsressourcen werden u. a. durch den jeweiligen soziokulturellen, historischen und biographischen Kontext (z. B. vorherrschende Erziehungsmuster und soziale Rollen) der Person geprägt, wodurch Gesundheit neben der individuellen auch eine gesellschaftliche Dimension umfasst.

Ein stark ausgeprägtes Kohärenzgefühl ist, über die Aktivierung verschiedener Copingstrategien (vorhandener Ressourcen), entscheidend für die erfolgreiche Bewältigung alltäglicher Anforderungen und Stressoren und somit für den Erhalt der Gesundheit. Dies verdeutlicht den Zusammenhang zur Stressforschung, in deren Kontext Antonovsky sein Konzept des Kohärenzgefühls entwickelte und um die salutogenetische Perspektive erweiterte⁹.

Lebenserfahrungen, die von Unvorhersehbarkeit, Unkontrollierbarkeit und Unsicherheit geprägt sind, können ebenso wie ungünstige Lebenssituationen zur Ausbildung eines schwachen Kohärenzgefühls führen. Dies weist sowohl auf die Bedeutung von Entwicklungs- und

4 Vgl. Faltermaier 2023, S. 56 ff., S. 79.

5 Vgl. ebd., S. 60.

6 Vgl. ebd., S. 63.

7 BZgA (Hrsg.): Was erhält Menschen gesund? Antonovskys Modell der Salutogenese – Diskussionsstand und Stellenwert, Köln, 2001, S. 28.

8 Vgl. Faltermaier 2023, S. 28f., S. 82.

9 Vgl. Faltermaier 2023, S.179ff., S. 195.

Erziehungsprozessen als auch auf die des sozialen Umfeldes hin. Entsprechend, so schlussfolgert Antonovsky, ist es wichtig, für Kinder und Jugendliche eine Welt zu schaffen, die konsistente Erfahrungen ermöglicht und Einflussnahme auf Entscheidungsprozesse zulässt¹⁰.

Diese Herangehensweise ermöglicht die vernetzte Darstellung und Analyse gesundheits- und sozialwissenschaftlicher Probleme aus vielfältigen Perspektiven. Mit Bezug auf den beruflichen Fokus sollte der problem- und handlungsorientierte Unterricht im Fach Gesundheit und Soziales im Vordergrund stehen. Dies wird durch die Bearbeitung von Fallsituationen in Anlehnung an das Modell der vollständigen Handlung sowie durch die Reflexion des eigenen Verhaltens auf Grundlage vielfältiger persönlicher Bezüge zu den jeweiligen Themen erreicht. Hierdurch wird das Verantwortungsbewusstsein für die eigene Gesundheit sowie die Gesundheitsmündigkeit im Sinne von Health Literacy gestärkt.

Dieses Konzept beschreibt die Kompetenzen, über die Lernende heute verfügen müssen, um ihre Gesundheit zu erhalten und zu fördern, Krankheiten zu vermeiden und Krankheiten erfolgreich zu bewältigen. Hierbei ist entscheidend, dass Lernende in der Lage sind, die dazu nötigen Informationen zu finden, zu verstehen, zu beurteilen und anzuwenden, d. h. Entscheidungen zu gesundheitsrelevanten Fragen zu treffen und sich eine Meinung zu bilden.

Sachkompetenz

Sachkompetenz bezeichnet die Bereitschaft und Fähigkeit, Aufgaben- und Problemstellungen fachlich richtig, selbstständig, zielorientiert und methodengeleitet zu lösen bzw. zu bearbeiten und das Ergebnis zu beurteilen.

Die Lernenden können u. a.

- gesundheits- und sozialwissenschaftliche Fachtexte inhaltlich erfassen und die Problemstellung mit wissenschaftlich-theoretischen Aussagen erörtern und vergleichen,
- Aufgaben- und Problemstellungen sachlich richtig, selbstständig, zielorientiert und methodengeleitet lösen, das Ergebnis beurteilen und Zusammenhänge einordnen,
- fachsprachliche korrekte Fallanalysen durchführen,
- theoretische Zugänge zum Verständnis des eigenen und allgemeinen Erlebens und Verhaltens erkennen und Wechselwirkungen erfassen,
- komplexe fachliche Fragestellungen, Zusammenhänge und Prozesse strukturiert darstellen,
- relevante Fragestellungen unter gesundheitspolitischer und sozialwissenschaftlicher Bedeutung analysieren,
- Maßnahmen der Prävention, Gesundheitsförderung, Therapie und Rehabilitation auswählen und die Ergebnisse beurteilen.

Methodenkompetenz

Methodenkompetenz umfasst die Fähigkeit und die Bereitschaft, Lernstrategien zu entwickeln, unterschiedliche Techniken und Verfahren sachbezogen und situationsgerecht anzuwenden. Sie ermöglicht den Lernenden mehr Selbstständigkeit und Selbstvertrauen, größere Sicherheit und Versiertheit in der Bearbeitung von Aufgaben- und Problemstellungen sowie Effizienz beim Lernen.

Die Lernenden können u. a.

- Arbeitsprozesse selbstständig planen, durchführen sowie die erworbenen Ergebnisse bewerten und präsentieren,
- wissenschaftliche Methoden bei eigenen Arbeitsprozessen anwenden,
- gesundheits- und sozialwissenschaftliche Fragen und Problemstellungen systematisch erschließen sowie Sachverhalte fachtheoretisch einordnen,
- graphische Darstellungen und Tabellen interpretieren,

¹⁰ Vgl. ebd. S. 197.

- aktuelle Veröffentlichungen unter Nutzung moderner Medien analysieren und Forschungsergebnisse in die Diskussion einbringen,
- Hypothesen bilden und auf Grundlage fachlicher Kenntnisse überprüfen,
- Handlungsstrategien zur Lösung gesundheitserzieherischer Probleme entwickeln und Lösungsvorschläge begründen.

Selbstkompetenz

Selbstkompetenz bezeichnet die individuelle Bereitschaft und Fähigkeit, die eigene Entwicklung zu gestalten. Sie schließt die reflektierte Entwicklung von Wertvorstellungen und die selbst bestimmte Bindung an Werte ein.

Die Lernenden können u. a.

- allgemeine Lernprozesse theoretisch fundiert betrachten und Schlussfolgerungen für das eigene Lernen ableiten,
- eigene Interessen und Meinungen zu gesundheits- und sozialwissenschaftlichen Themen wahrnehmen und angemessen vertreten,
- die Entwicklung der eigenen Persönlichkeit analysieren, Erkenntnisse auf ihre Biografie übertragen und das persönliche Gesundheitsverhalten bewerten,
- in gesundheitlichen und sozialwissenschaftlichen Problemsituationen Handlungsalternativen entwickeln und beurteilen.

Sozialkompetenz

Sozialkompetenz bezeichnet die individuelle Bereitschaft und Fähigkeit, soziale Beziehungen zu leben und zu gestalten, sich mit anderen rational und verantwortungsbewusst auseinanderzusetzen und zu verständigen.

Die Lernenden können u. a.

- gemeinsam mit anderen Gruppenmitgliedern Arbeitsprozesse planen, durchführen und auswerten und dabei eigene Interessen den Gruppenzielen unterordnen,
- unterschiedliche Herangehensweisen der Gruppenmitglieder erkennen und respektieren sowie Empathie und Rücksichtnahme praktizieren,
- im gemeinsamen Austausch gesundheitliche Fragestellungen unter individuellen, soziokulturellen und institutionellen Aspekten diskutieren,
- das eigene Gesundheitsbewusstsein sowie gesundheitsförderliches Verhalten im Gruppenkontext reflektieren.

3.2 Inhaltsbezogene Kompetenzen

3.2.1 Vielfalt von Gesundheit und Krankheit im Lebenslauf (Q1)

Die Entwicklungen in allen Lebensphasen haben eine besondere Bedeutung für die Gesundheits-Krankheits-Dynamik. Um wirksame Entwicklungsverläufe sowie Gesundheitszustände zu verstehen, wird ein genaues Verständnis über die zugrunde liegenden Abläufe sowie die Einbindung des Individuums in seine Umwelt benötigt. Krankheitsbezogene Veränderungen sind dabei das Ergebnis komplexer bio-psycho-sozialer Prozesse. Bevor pathologische Prozesse greifen, sind zunächst somatische Vorgänge des Lebenslaufs zu identifizieren. Unter dem Aspekt der Veränderlichkeit von Lebensumständen gilt grundlegend, ein Bewusstsein für präventive Verhaltensweisen zu schaffen.

Grundbegriffe und Modelle

Hinweise zu Gesundheit:

- Definition Gesundheit und Krankheit (Einführungsphase)
- Krankheitsentstehung und -verlauf (Einführungsphase)
- Prävention: Primär-, Sekundär-, Tertiärprävention (Einführungsphase)
- Pathologie der Tumoren (Einführungsphase)

Hinweise zu Sozialwissenschaften:

- Stress/Resilienz (Einführungsphase)
- Einflussfaktoren auf die Entwicklung (Q1)

Kompetenzbeschreibung Die Lernenden können	Lerninhalt
– Modelle zur pathogenetischen und salutogenetischen Betrachtungsweise von Gesundheit beschreiben und vergleichen. – die Bedeutung der Modelle für die Gesundheitsförderung und Prävention bewerten.	– pathogenetische Betrachtungsweise ▪ biomedizinisches Modell ▪ Risikofaktorenmodell – salutogenetische Betrachtungsweise ▪ bio-psycho-soziales Modell ▪ Modell der Salutogenese nach Aaron Antonovsky
– Gesundheitsförderung und Prävention als Handlungsfelder der gesundheitlichen Versorgung beschreiben. – ein Präventionskonzept in Anlehnung an das Modell der vollständigen Handlung anhand eines ausgewählten Gesundheitsproblems entwickeln.	– Präventionsstufen und -ebenen: medizinische Prävention, Verhaltens- und Verhältnisprävention – modifiziertes Modell der vollständigen Handlung: Analysieren, Problem benennen, Ziel formulieren, Maßnahmen entwickeln
– epidemiologische Daten als Mittel zur Einschätzung des Gesundheitszustandes der Bevölkerung auswerten.	– Prävalenz, Inzidenz, Morbidität, Mortalität, Letalität

Zytologie und Histologie

Kompetenzbeschreibung Die Lernenden können	Lerninhalt
– den Aufbau des Organismus in seiner Hierarchie beschreiben.	– strukturelle Ebenen: Moleküle, Atome, Zellorganellen, Zellen, Gewebe, Organe, Organsysteme, Organismus
– das Prinzip von Struktur und Funktion am Beispiel der Zelle erläutern.	– Zellbestandteile und deren Funktionen
– die Grundgewebearten des Körpers in Bezug auf Vorkommen und Funktion im Überblick beschreiben.	– Epithel- und Drüsengewebe, Binde- und Stützgewebe, Muskelgewebe, Nervengewebe

Blut und Herz-Kreislaufsystem

Hinweise zu Gesundheit:

- Erste Hilfe: lebensbedrohliche Situationen (Einführungsphase)
- Grundlagen der Mikrobiologie und Immunologie (Einführungsphase)
- Ernährungslehre (Einführungsphase)

Kompetenzbeschreibung Die Lernenden können	Lerninhalt
– die Zusammensetzung des Blutes übersichtlich darstellen. – den Zusammenhang von Bau und Funktion der einzelnen Blutbestandteile erklären.	– Aufgaben und Bestandteile des Blutes
– die Hämostase erklären. – das ABO- und Rhesussystem erläutern.	– Blutstillung und Blutgerinnung – Blutgruppen, Rhesusfaktor
– verschiedene Möglichkeiten der Transfusion beschreiben und Transfusionsreaktionen erklären. – die persönliche Einstellung zur Blutspende kritisch hinterfragen und Folgen ableiten.	– Blutprodukte: Erythrozytenkonzentrat, Plasma – Antigen-Antikörper-Reaktion – Ursachen und Folgen des Mangels an Blutprodukten
– die Anatomie und Physiologie des Herzens beschreiben.	– Bau des Herzens – Herzzyklus, Erregungsleitung, Herzleistung
– den Bau und die Funktion der Gefäße vergleichen. – die Mechanismen zur Regulation des Blutflusses erläutern. – die Kreisläufe beschreiben.	– Arterien, Venen, Kapillaren – Windkesselfunktion, Mechanismen des venösen Rückflusses – Körper-, Lungen- und Pfortaderkreislauf

Kompetenzbeschreibung Die Lernenden können	Lerninhalt
– Risikofaktoren zur Entstehung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen beurteilen. – den individuellen Lebensstil einschätzen und Gesundheitsrisiken ableiten. – die Bedeutung der Arteriosklerose als zentraler Faktor für die Entstehung von ischämischen Herz-Kreislauf-Erkrankungen erklären.	– Risikofaktorenmodell im Kontext von Herz-Kreislauf-Erkrankungen – Überblick über beeinflussbare und nicht beeinflussbare Risikofaktoren – Entstehung der Arteriosklerose, Thrombose und Embolie als Folgen
– die Koronare Herzkrankheit charakterisieren und vom Myokardinfarkt abgrenzen. – die Fachterminologie sinnvoll einsetzen. – Statistiken und graphische Darstellungen zur Morbidität, Mortalität und Kausalität analysieren und interpretieren.	– Pathogenese, Symptome, Diagnostik, Therapie, Rehabilitation, Prävention und Gesundheitsförderung

Entwicklung

Hinweise zu Gesundheit:

- bio-psycho-soziales Modell (Q1)

Hinweise zu Sozialwissenschaften:

- kognitive Prozesse (Einführungsphase)
- Familie und Gruppe als Sozialisationsinstanz (Einführungsphase)
- Kommunikation und Interaktion (Einführungsphase)
- endogene, exogene, autogene Einflussfaktoren (Q2)
- Persönlichkeitstheorie Rogers (Q4)

Kompetenzbeschreibung Die Lernenden können	Lerninhalt
– die Bedeutung von Entwicklung als ununterbrochenen Prozess über die verschiedenen Lebensphasen wissenschaftlich erklären. – spezifische Entwicklungstheorien unterscheiden und verknüpfen. – die Bedeutung der Bindung für die menschliche Entwicklung in allen Lebensphasen benennen. – mit ihrem erworbenen Wissen positiv auf die Entwicklung ihrer Mitmenschen einwirken, indem sie Entwicklungsbögen erstellen und analysieren. – die eigene Entwicklung analysieren und Bereitschaft zur Optimierung zeigen. – das eigene Resilienzverhalten reflektieren. – das Bindungsverhalten auf die weitere Persönlichkeitsentwicklung hinterfragen. – die eigene Biografie auf ausgewählte Entwicklungstheorien übertragen.	– Entwicklungsbegriff – Merkmale der Entwicklung – Einflussfaktoren auf Entwicklung – Entwicklungsstörungen – spezifische Entwicklungstheorien: Piaget, Erikson, Havighurst, Kohlberg, Maslow, Freud – körperliche, motorische, sprachliche und emotionale Entwicklungsverläufe in allen Lebensphasen bis zum Tod – Resilienz als fester Bestandteil in der Entwicklung – Bindungsbegriff – Bindungstheorien: Mary Ainsworth, John Bowlby

3.2.2 Gesundheit und Pädagogik in Wechselwirkung (Q2)

Ein zentraler Bestandteil optimaler Entwicklung ist ein gesundheitsorientierendes Verhalten, bestehend aus Kenntnissen von Organsystemen, deren physiologischen Abläufen sowie Risikofaktoren, Behandlung und Prävention von Erkrankungen. In diesem Zusammenhang ist es unerlässlich, Erziehung in allen ihren Aspekten zur Ausbildung eines gesundheitsförderlichen Verhaltens heranzuziehen. Exemplarisch soll dabei der Einfluss der Erziehung bei vermeidbarem Risikoverhalten wie Rauchen oder Fehlernährung betrachtet werden.

Atmungssystem

Hinweise zu Gesundheit:

- Tumorphathologie (Einführungsphase)
- Allergien (Einführungsphase)
- Schock (Einführungsphase)

Hinweise zu Sozialwissenschaften:

- Motivation (Einführungsphase)
- endogene, exogene, autogene Einflussfaktoren auf die Entwicklung (Q1)

Kompetenzbeschreibung Die Lernenden können	Lerninhalt
– den Zusammenhang von Bau und Funktion der Atmungsorgane erläutern.	– obere und untere Atemwege – Pleura
– die Vorgänge der Atemphysiologie beschreiben.	– äußere Atmung, Atemmechaniken, Totraumbelüftung – Komponenten des Gasaustausches: Atemgasdiffusion, Atemgastransport im Blut – Bedeutung der inneren Atmung
– den Zusammenhang von Ätiologie, Pathogenese und typischen Symptomen ausgewählter Atemwegserkrankungen erklären.	– ausgewählte Atemwegserkrankungen: Pneumonie, Asthma bronchiale, Bronchialkarzinom
– das eigene Gesundheitsverhalten in Bezug auf das Rauchen reflektieren – präventive Möglichkeiten zur Förderung des Nichtrauchens differenzieren.	– gesundheitliche Auswirkungen des Rauchens auf den Organismus – Maßnahmen der verschiedenen Präventionsebenen und -stufen

Verdauungssystem und Stoffwechsel

Hinweise zu Gesundheit:

- Pathologie der Tumoren (Einführungsphase)
- Ernährungslehre (Einführungsphase)
- lebensbedrohliche Situationen (Einführungsphase)

Hinweise zu Sozialwissenschaften:

- Motivation (Einführungsphase)
- endogene, exogene, autogene Einflussfaktoren auf die Entwicklung (Q1)

Kompetenzbeschreibung Die Lernenden können	Lerninhalt
– den Weg der Nahrung beschreiben sowie den Zusammenhang von Bau und Funktion der Teile des Verdauungssystems erklären.	– Mundhöhle mit Speicheldrüsen, Speiseröhre, Magen, Dünndarm, Dickdarm
– Merkmale der Drüsenarten unterscheiden. – die Lage, den Bau und die Funktionen von Bauchspeicheldrüse und Leber erläutern.	– endokrine und exokrine Drüsen – makroskopischer und mikroskopischer Bau des Pankreas und der Leber – Lagebeziehung zu benachbarten Bauchorganen – Funktionen mit Bedeutungen für den Gesamtorganismus
– Darmkrebs als eine der häufigsten bösartigen Tumorerkrankungen charakterisieren.	– Risikofaktoren, Symptome, Therapie und Prävention des Kolonkarzinoms
– das Krankheitsbild der Adipositas erläutern und die Eignung verschiedener Ernährungskonzepte zur Gewichtsreduktion bewerten.	– Ursachen, Symptome und Folgen von Adipositas – Ernährungskonzepte, z. B. Low Carb, Low Fat, Intervallfasten
– Diabetes mellitus Typ 1 und 2 miteinander vergleichen.	– Ätiologie, Leitsymptome, Diagnostik – Therapie- und Präventionsmaßnahmen
– die Arten der Blutzuckerentgleisung vergleichen und Maßnahmen der Ersten Hilfe ableiten. – das Risiko diabetischer Spätschäden begründen.	– Hypo- bzw. Hyperglykämie – Spätschäden als Folgen von Makro- und Mikroangiopathien
– das Disease Management Programm (DMP) als strukturiertes Behandlungsprogramm für chronisch Erkrankte am Beispiel des Diabetes mellitus erläutern.	– allgemeine Ziele des DMP – Leistungen des DMP für Diabetespatienten
– Leberzirrhose als lebensbedrohliche Erkrankung erklären und Symptome begründen.	– Ätiologie, Pathogenese, Symptome der Leberzirrhose

Erziehung

Hinweise zu Gesundheit:

- Gesundheitsmodelle (Q1)

Hinweise zu Sozialwissenschaften:

- Kommunikation und Interaktion (Einführungsphase)
- Familie und Gruppe als Sozialisationsinstanz (Einführungsphase)
- Einflussfaktoren auf die Entwicklung (Q1)
- Lerntheorien (Q3)

Kompetenzbeschreibung Die Lernenden können	Lerninhalt
– den Begriff Erziehung definieren und unter dem Kontext der Erziehbarkeit und Erziehungsbedürftigkeit des Menschen sowie dessen Sonderstellung begründen. – Sozialisation, Enkulturation und Personalisation als Aufgabe der Erziehung erklären. – verschiedene Kommunikationsmodelle und Erziehungsstile fachlich erschließen und hinterfragen. – das Zusammenwirken von endogenen, exogenen und autogenen Faktoren ableiten und in spezifischen sozialen Kontexten analysieren. – fehlende und unzulängliche Erziehung beschreiben sowie mögliche Auswirkungen auf die soziale Gruppe übertragen. – sich mit den Aufgaben der Erziehung kritisch auseinandersetzen und sie auf die eigene Biografie übertragen. – die eigene soziale Rolle im Wandel innerhalb der Sozialisationsinstanzen hinterfragen. – über selbst erfahrene Erziehungssituationen reflektieren, entsprechende Ressourcen erkennen und diese zur Bewältigung aktueller und neuer Lebenssituationen ableiten. – Aspekte der eigenen Lebenswelt reflektieren und auf die entsprechenden Lerninhalte transferieren.	– Begriff und Merkmale von Erziehung – Anthropologische Thesen – fehlende und unzulängliche Erziehung – Einflussfaktoren auf die Erziehung – Aufgaben und Ziele von Erziehung – Erziehung als Interaktions-/ Kommunikationsprozess – Erziehungsstilkonzepte: Lewin, Tausch/Tausch, Tschöpe-Scheffler – Erziehung und Sozialisation: Familie als Sozialisationsinstanz und soziale Gruppe, Parenting-Konzept – Erziehungsmaßnahmen

3.2.3 Lernen als konstruktiver Prozess der Gesundheitsförderung (Q3)

Gesundheit unterliegt einer Vielzahl an unterschiedlichen Einflussfaktoren. Dabei muss verstärkt das Gesundheitsverhalten analysiert werden. Lerntheoretische Ansätze werden herangezogen, um gesundheitsförderndes Verhalten bei unterschiedlichen Personengruppen zu stärken. Dies muss ab dem frühen Lebensalter in allen Lebensbereichen erlernt werden. Regelmäßige Aktivität ist eine Grundlage physischer und psychischer Gesundheit. Das innere Gleichgewicht ist wichtig für Gesundheit und Wohlbefinden.

Harnsystem

Hinweise zu Gesundheit:

- Wasserhaushalt (Einführungsphase)

Kompetenzbeschreibung Die Lernenden können	Lerninhalt
– den Bau und die Funktion der Harnorgane beschreiben.	– makroskopischer und mikroskopischer Bau der Niere – ableitende Harnwege
– die Bedeutung des Harnsystems für die Homöostase und die Hormonbildung begründen.	– Begriffsklärung Homöostase: Wasserhaushalt, Elektrolythaushalt, Säure-Base-Haushalt – Renin, Erythropoetin, Vitamin D
– die Mechanismen der Harnbildung erläutern.	– Vorgänge der Primärharn- und Sekundärharnbildung
– pathologische Entgleisungen des Wasserhaushalts charakterisieren.	– Ursachen und Folgen einer Hypo- bzw. Hyperhydratation
– das Krankheitsbild der Zystitis erläutern sowie Maßnahmen der Therapie und Prävention ableiten.	– Ätiologie, Pathogenese, Symptome, Komplikationen, Therapie, Prävention der Zystitis
– mögliche Ursachen einer Niereninsuffizienz und deren Folgen für den Organismus begründen.	– chronische Niereninsuffizienz
– die Prinzipien der Hämo- und Peritonealdialyse erläutern und die Folgen einer Dialysepflichtigkeit für die Betroffenen bewerten.	– Voraussetzungen, Funktionsweise, physikalische Vorgänge der Nierenersatztherapien – Vor- und Nachteile – mögliche Komplikationen, Ernährungseinschränkungen, Einschränkungen im Alltag
– die Voraussetzungen für eine Organtransplantation erläutern sowie ethische, rechtliche und medizinische Aspekte der Organspende diskutieren.	– Zustimmungsmöglichkeiten, Hirntodfeststellung, Gewebsverträglichkeit, Eignung der Organe – unterschiedliche internationale gesetzliche Regelungen

Aufbau und Funktion des aktiven und passiven Bewegungsapparates

Hinweise zu Gesundheit:

- Allgemeine Krankheitslehre (Einführungsphase)
- Zytologie und Histologie (Q1)

Hinweise zu Sozialwissenschaften:

- Wissenschaftliche Methoden (Einführungsphase)
- Entwicklung (Motorik) (Q1)

Kompetenzbeschreibung Die Lernenden können	Lerninhalt
- den Zusammenhang zwischen Aufbau und Funktion des Muskel- und Skelettsystems im Überblick darstellen.	- makroskopischer und mikroskopischer Aufbau des Skelettmuskels - Teile des menschlichen Skeletts und ihre Lage: Lage- und Richtungsbezeichnungen - Skelettsystem: Grundaufbau des Röhrenknochens, Festigkeit und Elastizität der Knochen - Bau eines Gelenks am Beispiel des Kugelgelenks
- den Zusammenhang zwischen Aufbau und Funktion am Beispiel der Wirbelsäule erklären.	- Abschnitte der Wirbelsäule - Grundbauplan eines Wirbels - Zwischenwirbelscheiben
- den Verhaltensfaktor körperliche Aktivität in Bezug auf die Gesundheit beurteilen. - gesundheitsfördernde Handlungskonzepte zur körperlichen Aktivität in Anlehnung an das Modell der vollständigen Handlung entwickeln.	- Präventionsstufen und -ebenen: medizinische Prävention, Verhaltens- und Verhältnisprävention: - rücken- und gelenkschonende Bewegungsmuster für ausgewählte Alltagstätigkeiten - modifiziertes Modell der vollständigen Handlung
- das eigene Bewegungsverhalten reflektieren.	- Selbsteinschätzung durch ein Bewegungsprotokoll
- Erkrankungen des Bewegungsapparates am Beispiel von Osteoporose und Bandscheibenvorfall beschreiben.	- Ätiologie, Pathogenese, Symptome, Möglichkeiten der Therapie, Pflege, Rehabilitation und Prävention beider Erkrankungen

Lernen

Hinweise zu Sozialwissenschaften:

- kognitive Prozesse (Einführungsphase)
- Erziehungsmaßnahmen (Q2)

Kompetenzbeschreibung Die Lernenden können	Lerninhalt
– den Begriff Lernen definieren. – verschiedene Lerntheorien und Lernprozesse erklären, anwenden und vergleichen. – Menschenbilder des Behaviorismus mit anderen Konzepten vergleichen und gegenüberstellen. – Elemente der Verhaltensveränderungen bestimmen. – ihr eigenes Lernverhalten in der Gruppe kritisch reflektieren und vergleichen. – Verantwortung für das eigene Lernverhalten übernehmen. – anhand der eigenen Biografie Schwerpunkte einer Verhaltensveränderung reflektieren. – effektive Lerntechniken entwickeln und anwenden.	– Lernbegriff, Lernarten und Lernprozesse – Gedächtnis und Gedächtnishemmung – Lerntheorien • behavioristische Theorien: Konditionierung (inkl. Menschenbild und Kritik) ▪ klassisches Konditionieren: Pawlow ▪ operantes Konditionieren: Skinner, Thorndike • sozial-kognitive Theorie (inkl. Menschenbild und Kritik) • Lernen durch Einsicht (inkl. Menschenbild und Kritik) – Wiederholung Locus of Control und HAPA-Modell in Verbindung mit den Lerntheorien

3.2.4 Gesundheit und Identität (Q4)

Es besteht ein Zusammenhang zwischen Identität und Gesundheit mit dem Ziel der adäquaten Lebensbewältigung. Gesundheit unterliegt keinem konstanten Gleichgewichtszustand, sondern muss in der Auseinandersetzung mit inneren und äußeren Einflussfaktoren stetig neu angepasst werden. Psychisches Wohlbefinden ist eng mit neuronalen und hormonellen Prozessen verknüpft.

Nach dem salutogenetischen Modell sind die Widerstandsressourcen zu erkennen und zu stärken, um den Erhalt und die Verbesserung individueller Gesundheit, Lebenszufriedenheit und Lebensqualität unter dem Aspekt der Selbstbestimmung zu realisieren.

Nervensystem

Hinweise zu Sozialwissenschaften:

- kognitive Prozesse (Einführungsphase)
- Lernen (Q3)

Kompetenzbeschreibung Die Lernenden können	Lerninhalt
– die Einteilung des Nervensystems beschreiben.	– anatomische und funktionelle Einteilung im Überblick
– den Bau des Nervensystems beschreiben.	– Bau der markhaltigen Nervenzelle – Bau und Funktion von Gehirn und Rückenmark
– die Funktionsweise der Nervenleitung sowie der synaptischen Erregungsübertragung erklären.	– synaptische Erregungsübertragung und grundlegende Neurotransmitter
– Ursachen für die Zunahme von neurologischen Erkrankungen analysieren.	– Epidemiologie von Apoplex und Alzheimer-Demenz – Zusammenhang zu Lebensstil, soziokulturellen Faktoren und demografischer Entwicklung
– die Krankheitsbilder Apoplex und Alzheimer-Demenz charakterisieren.	– Ätiologie, Pathogenese, Symptome, Diagnostik, Prävention und Gesundheitsförderung beider Krankheitsbilder
– Ziele und Maßnahmen der Therapie und Rehabilitation ableiten.	– allgemeine Maßnahmen zur Erhaltung bzw. Förderung der Selbstständigkeit bei Apoplex und Alzheimer-Demenz – Grundlagen des Bobath-Konzeptes und Realitäts-Orientierungs-Trainings

Hormonsystem und Stressregulation

Hinweise zu Gesundheit:

- modifiziertes Modell der vollständigen Handlung (Q1)
- Diabetes mellitus (Q1)
- Arteriosklerose (Q1)

Hinweise zu Sozialwissenschaften:

- Stress, Transaktionales Stressmodell nach Lazarus, Copingstrategien (Einführungsphase)

Kompetenzbeschreibung Die Lernenden können	Lerninhalt
- den Aufbau und die Funktion des Hormonsystems beschreiben.	- Hierarchie der Hormondrüsen - Prinzipien der hormonellen Steuerung: Rezeptoren, Schlüssel-Schloss-Prinzip - Lage und Funktion der Hormondrüsen im Überblick
- den Begriff Stress erklären. - die Arten von Stress unterscheiden.	- Begriffe Stress, Eustress, Distress, Stressoren
- die Entstehung von Stress aus biomedizinischer und salutogenetischer Sicht erklären und die Folgen ableiten.	- Zusammenwirken von Nerven- und Hormonsystem bei der Stressreaktion - Zusammenhang zwischen Bewertung und Bewältigungsstrategien - physiologische und psychologische Folgen
- Strategien zur Vermeidung von und zum Umgang mit belastenden Situationen entwickeln, anwenden und reflektieren. - gesundheitsfördernde Handlungskonzepte in Anlehnung an das Modell der vollständigen Handlung zur Stressbewältigung entwickeln.	- Präventionsstufen und -ebenen: medizinische Prävention, Verhaltens- und Verhältnisprävention - modifiziertes Modell der vollständigen Handlung

Geschlechtssystem

Hinweise zu Gesundheit:

- Pathologie der Tumoren (Einführungsphase)
- Prävention und Gesundheitsförderung (Einführungsphase)

Kompetenzbeschreibung Die Lernenden können	Lerninhalt
– den Zusammenhang von Bau und Funktion der Geschlechtsorgane erläutern. – den Menstruationszyklus mit Hilfe der hormonellen Steuerung erklären.	– weibliche und männliche Geschlechtsorgane – Phasen des Menstruationszyklus
– die Vor- und Nachteile der verschiedenen Methoden der Empfängnisverhütung benennen.	– Definition Pearl-Index – Methoden der Empfängnisverhütung: hormonelle, chemische und natürliche Methoden, Barrieremethoden
– die Inhalte der Krebsvorsorgeuntersuchungen beschreiben. – zur Notwendigkeit von Krebsvorsorgeuntersuchungen sachlich argumentieren. – das eigene Gesundheitsverhalten bewerten und Schlussfolgerungen für künftiges Handeln ableiten.	– Krebsvorsorgeuntersuchungen Mamma, weibliche Genitale und Prostata
– das Krankheitsbild Mammakarzinom erläutern. – Statistiken und graphische Darstellungen zur Morbidität, Mortalität und Kausalität des Mammakarzinoms analysieren und interpretieren.	– Ätiologie, Pathogenese, Risikofaktoren, Symptome, Diagnostik, Therapie, Komplikationen, Rehabilitation, Prävention und Gesundheitsförderung

Persönlichkeit

Hinweise zu Sozialwissenschaften:

- sozialwissenschaftliche Methoden (Einführungsphase)
- Familie und Gruppe als Sozialisationsinstanz (Einführungsphase)
- Entwicklung (Q1)

Kompetenzbeschreibung Die Lernenden können	Lerninhalt
– den Begriff Persönlichkeit erklären und vom Begriff Charakter abgrenzen. – die Struktur, Dynamik und Entwicklung der Persönlichkeit mithilfe ausgewählter Persönlichkeitstheorien erklären. – einen Perspektivwechsel vollziehen, um einen wertschätzenden Umgang in der Gruppe zu praktizieren. – sich kritisch mit den Theorien auseinanderzusetzen, indem sie die eigene Persönlichkeit analysieren und hinterfragen. – Schlussfolgerung für die eigene Persönlichkeitsentwicklung ziehen. – ausgewählte sozialwissenschaftliche Methoden wie z. B. Persönlichkeitstests anwenden.	– Begriffe Person, Persönlichkeit, Charakter, Temperament – Ziele und Merkmale von Persönlichkeitstheorien – Persönlichkeitstheorien: Freud, Rogers, Eysenck und andere – personale und psychische Disposition – aktueller Lebensweltbezug (Diversität)

4 Einschätzung der Kompetenzentwicklung

4.1 Zur Leistungseinschätzung im kompetenz- und standardorientierten Unterricht

Die Kompetenzentwicklung der Lernenden einzuschätzen heißt, dass deren Leistungen mit Hilfe geeigneter Instrumente beobachtet bzw. ermittelt, verbal eingeschätzt oder benotet werden. Daraus sind individuelle Fördermaßnahmen abzuleiten, die den Lernenden Erfolg ermöglichen und das Vertrauen in die eigene Leistungsfähigkeit stärken.

Grundlage der Leistungsbewertung sind das Thüringer Schulgesetz (§ 48), die Thüringer Allgemeine Schulordnung für die berufsbildenden Schulen (§§ 42, 44, 45 und 46) und die Thüringer Schulordnung für das berufliche Gymnasium (§ 5) in der jeweils geltenden Fassung.

Das Kompetenzmodell der Thüringer Lehrpläne bedingt einen erweiterten Lernbegriff. Er wird durch fachlich-inhaltliche, sozial-kommunikative, methodisch-strategische und persönliche Dimensionen des Lernens konkretisiert. Dies führt zu einem erweiterten Leistungsbegriff, der die gesamte Lernentwicklung der Lernenden ganzheitlich erfasst und reflektiert.

Ein pädagogisches Leistungsverständnis, das auf die Entwicklung von Lernkompetenz fokussiert ist, wird durch eine Leistungsbewertung beschrieben, die

- produkt- und prozessbezogen ist,
- sowohl individuelles als auch kooperatives Lernen einschließt,
- die individuelle Eigenverantwortung, die Leistungsbereitschaft und Lernmotivation als Bedingungen für erfolgreiches Lernen fördert,
- die Reflexion und Einschätzung der Lernprozesse und Leistungen unterstützt.

Die Leistungsbewertung erfolgt auf der Basis transparenter Kriterien. Diese werden aus der Zielbeschreibung für die Kompetenzbereiche in den Lehrplänen hergeleitet und beziehen sich auf die Qualität des zu erwartenden Produkts und des Lernprozesses sowie der Präsentation des Arbeitsergebnisses.

Produktbezogene Kriterien sind beispielsweise

- Aufgabenadäquatheit,
- fachliche Richtigkeit und Vollständigkeit,
- logische Struktur der Darstellung,
- Beachtung der kommunikativen Funktion unter Verwendung von Bildungs- und Fachsprache,
- sachgerechte und kritische Nutzung von Informationen aus verschiedenen Quellen,
- Begrenzung der Darstellung auf das Erforderliche,
- angemessene formale Gestaltung.

Prozessbezogene Kriterien sind beispielsweise

- Qualität des Arbeitsprozesses unter Berücksichtigung des Zeitmanagements, z. B. beim Planen, Durchführen, Auswerten und Dokumentieren/Protokollieren,
- auswahl- und sachgerechtes Anwenden von Lernstrategien,
- Kommunikation, Kooperation, Kollaboration,
- sachgerechtes und sicheres Ausführen von Arbeitstechniken,
- Effizienz des methodischen Vorgehens, z. B. bei der Lösung komplexer Aufgaben,
- konstruktiver Umgang mit Fehlern und Hinweisen im Prozess selbst,
- Umgang mit formativen Rückmeldungen.

Präsentationsbezogene Kriterien sind beispielsweise

- inhaltliche Qualität der Darstellung,
- klare Strukturierung,
- adressaten- und situationsgerechte Darstellung,
- sinnvolle Nutzung von Medien,
- ausgewogenes Zeitmanagement.

Reflexionsbezogene Kriterien sind insbesondere

- begründete Darstellung und Diskussion von Lösungswegen,
- individuelle Bezugnahme zum eigenen Lernweg,
- Reflexion der einbezogenen Informationen,
- Beschreibung der Organisation des Lösungsprozesses.

In die Leistungsbewertung der Lernenden ist die kognitive Komplexität der Lerntätigkeiten beim Lösen von Aufgaben angemessen einzubeziehen. Daher sind in den Aufgabenstellungen zur Leistungsermittlung die durch die Nationalen Bildungsstandards und die Einheitlichen Anforderungen in der Abiturprüfung (EPA) als Orientierungsrahmen beschriebenen Anforderungsbereiche I bis III entsprechend zu berücksichtigen.

Anforderungsbereich I (Reproduktion)

- Wiedergabe von Sachverhalten und Kenntnissen im gelernten Zusammenhang
- Anwenden und Beschreiben geübter Lernstrategien, Verfahren sowie Arbeitstechniken

Anforderungsbereich II (Reorganisation und Transfer)

- selbstständiges Auswählen, Anordnen, Verarbeiten, Erklären und Darstellen bekannter Sachverhalte unter vorgegebenen Gesichtspunkten in bekanntem Zusammenhang
- selbstständiges Übertragen und Anwenden des Gelernten auf vergleichbare neue Zusammenhänge und Sachverhalte

Anforderungsbereich III (Reflexion und Problemlösung)

- selbstständiges Auswählen sowie Anwenden von Arbeitstechniken und Verfahren auf neue Problemstellungen
- Verarbeiten von komplexen Sachverhalten und selbstständiges, problembezogenes Deuten, Folgern, Verallgemeinern, Begründen und Werten
- Reflektieren des eigenen Vorgehens

Die oben genannten Anforderungsbereiche und Kriterien werden aus der Sicht des jeweiligen Faches unter 4.2 konkretisiert. Sie sind in ihrer wechselseitigen Abhängigkeit zu sehen, wobei der Schwerpunkt der zu erbringenden Leistungen im Anforderungsbereich II liegt. Gute und sehr gute Bewertungen setzen Leistungen voraus, die über den Anforderungsbereich II hinausgehen und mit einem wesentlichen Anteil dem Anforderungsbereich III zuzuordnen sind. Auf der Grundlage der in den Nationalen Bildungsstandards formulierten Leistungserwartungen werden Kompetenzstufenmodelle für ausgewählte Zeitpunkte der Schullaufbahn entwickelt, die es erlauben, den Stand der Kompetenzentwicklung der Lernenden einzuschätzen. Bei Leistungsnachweisen sollte demzufolge auch die Zuordnung der ausgewählten Aufgaben zu den Kompetenzstufen angemessen berücksichtigt werden.

Der ganzheitliche Kompetenzansatz der Thüringer Lehrpläne erfordert, dass auch die Leistungseinschätzung ganzheitlich erfolgt und alle Kompetenzbereiche einbezieht. Dementsprechend sind Lernaktivitäten mit Aufgabenstellungen in unterschiedlichen Arbeitsformen zu verknüpfen.

4.2 Leistungsbewertung im Fach Gesundheit und Soziales

Grundlage der Leistungsbewertung bilden die Thüringer Schulordnung für das berufliche Gymnasium, die EPA¹¹ im Fach Gesundheit und Soziales und das Kompetenzmodell der Thüringer Lehrpläne.

Bei der Leistungsbewertung im Fach Gesundheit und Soziales wird den Vorgaben unter 4.1 entsprochen.

Mögliche Bewertungskriterien können dabei u. a. sein:

- korrekte Verwendung der Fachtermini und Sicherheit im Umgang mit der Fachsprache,
- Beherrschung verschiedener Arbeitstechniken und sicherer Umgang mit Fachtexten und Statistiken,
- verständliche Darlegung gesundheits- und sozialwissenschaftsbezogener Sachzusammenhänge unter Einbeziehung von Fallbeispielen und deren Analyse,
- klar strukturierte Darstellung und sinnvolle Verknüpfung von anatomisch-physiologischen und pathologischen mit psychologischen und pädagogischen Sachverhalten,
- Bildung einer fundierten eigenen Meinung zu gesundheits- und sozialwissenschaftlichen Problembereichen durch die Auseinandersetzung mit wissenschaftlichen Erkenntnissen,
- Ableiten von Schlussfolgerungen für das eigene gesundheitsbewusste und pädagogische Handeln,
- Komplexität und Differenziertheit des fachlichen Urteilsvermögens,
- selbstständige Planung und Durchführung von Arbeitsvorhaben unter Anwendung geeigneter Methoden und Arbeitstechniken der Gesundheits- und Sozialwissenschaften,
- angemessene Formen mediengestützter Präsentationen,
- Reflexion des eigenen Lernprozesses und des Lernprozesses der Lerngruppe.

Bei der Bewertung der Lernendenleistung im Fach Gesundheit und Soziales sind die drei Anforderungsbereiche angemessen zu berücksichtigen.

Anforderungsbereich I (Reproduktion) umfasst z. B.

- das Definieren fachwissenschaftlicher Begriffe aus den Bereichen Gesundheit, Pädagogik/Psychologie und Soziologie,
- das Benennen, Skizzieren und Beschreiben von anatomischen Strukturen, physiologischen Vorgängen sowie pathologischen Veränderungen,
- das Wiedergeben von Theorien, z. B. zu Entwicklung, Erziehung, Lernen und Persönlichkeit,
- das Darstellen von gesundheits- und sozialwissenschaftlichen Grundmodellen, z. B. Gesundheits- und Krankheitsmodelle, Präventions- und Verhaltensmodelle.

Anforderungsbereich II (Reorganisation und Transfer) umfasst z. B.

- das Erklären von Zusammenhängen, z. B. von Bau und Funktion,
- das Begründen von Symptomen,
- das Ableiten von geeigneten Maßnahmen der Prävention, Diagnostik und Therapie,
- die Analyse bekannter Sachverhalte mithilfe grafischer Darstellungen, z. B. Auswertung aktueller Statistiken,
- die Vernetzung bekannter Fachinhalte in erweitertem Zusammenhang, z. B. HAPA-Modell und Salutogenese,
- die Übertragung der Sachkompetenzen auf vergleichbare Inhalte, z. B. Modelle und Theorien auf Handlungssituationen.

11 Einheitliche Prüfungsanforderungen in der Abiturprüfung der KMK

Anforderungsbereich III (Reflexion und Problemlösung) umfasst z. B.

- das kritische Hinterfragen des eigenen Gesundheitsbewusstseins und daraus resultierenden Verhaltensgewohnheiten, z. B. Ernährungs- und Rauchverhalten,
- das selbstständige, problembezogene Begründen von Lösungsvorschlägen,
- die Bewertung der Schlüsselrolle des eigenverantwortlichen Handelns,
- das Diskutieren von komplexen Problemstellungen im aktuellen Kontext, z. B. Demenzforschung, Persönlichkeitsentwicklung, Resilienz.

Die Anforderungsbereiche sind in ihrer wechselseitigen Abhängigkeit zu sehen, wobei der Anforderungsbereich III die Anforderungsbereiche I und II, der Anforderungsbereich II den Anforderungsbereich I einschließt. Die Leistungsnachweise beinhalten Aufgaben aus allen drei Bereichen und ermöglichen somit eine Bewertung, die das gesamte Notenspektrum umfasst. Die Gewichtung der Aufgabenbereiche erfolgt nach EPA.